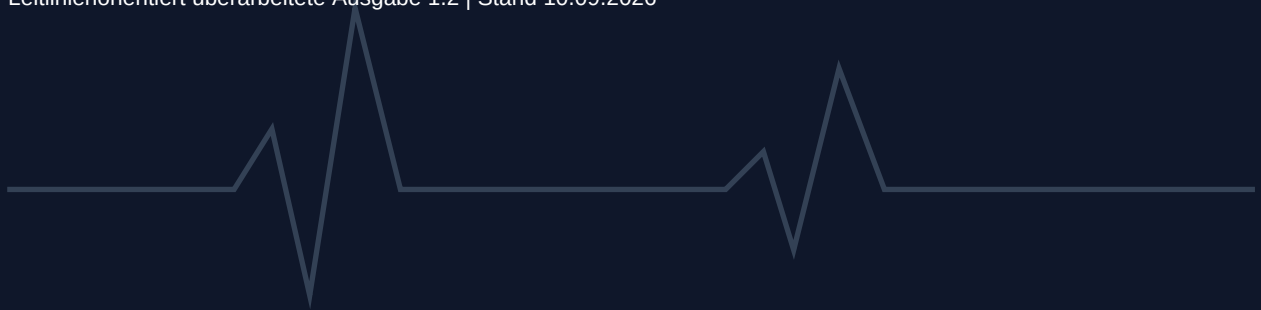
# EINSATZDECK

RS BASIS SET #1

28 prüfungsnahe Fallbeispiele für Rettungssanitäter

Prüflingskarten | Spielleiterkarten | ABCDE | SAMPLER / OPQRST | Verlauf | Fachgespräch | Auswertung

Leitlinienorientiert überarbeitete Ausgabe 1.2 | Stand 10.09.2026



# So benutzt du das EinsatzDeck

Jeder Fall besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Seiten. Die erste Seite ist die **Prüflingskarte** und enthält nur Alarmierung, Einsatzort und ersten Eindruck. Die zweite Seite gehört zur **Spielleitung** und enthält Befunde, Anamnese, Verlauf, erwartete Kernmaßnahmen, Fachgespräch und ein einfaches 100-Punkte-Schema.

### Empfohlener Ablauf

1. Spielleitung liest die Rückseite, ohne die Diagnose zu verraten.
2. Prüfling arbeitet strukturiert nach ABCDE und fordert Befunde aktiv an.
3. Vitalwerte und Informationen werden nur auf passende Untersuchung/Frage herausgegeben.
4. Der Verlauf wird passend zu den Maßnahmen ausgespielt.
5. Danach erfolgt Debriefing und Fachgespräch.

### Wichtiger Hinweis

Dieses Material dient ausschließlich Ausbildung, Simulation und Prüfungsvorbereitung. Es ersetzt keine lokalen SOP, BPR/SAA, ärztliche Anweisungen, aktuellen Leitlinien oder die Beurteilung einer realen Einsatzlage. Kompetenzen von Rettungssanitätern unterscheiden sich regional und organisationsbezogen. Medikamentengaben und invasive Maßnahmen sind deshalb nur im Rahmen der jeweils gültigen lokalen Regelungen und persönlichen Qualifikation durchzuführen.

## Bewertungsvorschlag

Das 100-Punkte-Schema ist eine nichtamtliche Trainingshilfe. Für NRW orientiert es sich an den Prüfkriterien der RettAPrVO NRW: Gesamtsituation, medizinisch-technische Geräte, Sofortmaßnahmen, Dokumentation, Transportbereitschaft/Übergabe sowie Assistenz. Kritische Fehlleistungen mit möglicher schwerer Patientenschädigung werden unabhängig vom Punktestand als Nichtbestehensgrund gewertet.

Kardiologie / Kreislauf

KARTE 01

# Thoraxschmerz

PRÜFLINGSKARTE

| | |
|---|---|
| Einsatzmeldung | **Brustschmerzen, männlich, 58 Jahre** |
| Einsatzort | Wohnung, 2. Obergeschoss. Ehefrau vor Ort. |

### Situation beim Eintreffen

Der Patient sitzt auf dem Sofa, wirkt unruhig und blass und hält sich die Hand auf die Brust.

### Dein Auftrag

Versorge die Patientin bzw. den Patienten strukturiert. Befunde und Anamnesedaten erhältst du nur, wenn du sie aktiv erhebst oder die entsprechende Untersuchung/Maßnahme ankündigst. Begründe deine Prioritäten und triff am Ende eine Transport- und Übergabeentscheidung.

## Notizen / Arbeitsstruktur

**A** _____

**B** _____

**C** _____

**D** _____

**E** _____

**SAMPLER / OPQRST** _____

**Maßnahmen** _____

**Transport / Übergabe** _____

Kurztraining: 10-15 Min. | Prüfungssimulation NRW: 20-45 Min. inkl. Fachgespräch.

# Thoraxschmerz

## Patient / Ausgangslage

58 Jahre, männlich. Seit etwa 25 Minuten plötzlich einsetzender starker Druck hinter dem Brustbein.

**Erster Eindruck:** Wach, voll orientiert, blass, kaltschweißig, deutlich beunruhigt. Spricht in ganzen Sätzen.

## Lösung

**Arbeitshypothese:** Akutes Koronarsyndrom, bei passender EKG-Konstellation STEMI.

**Differenzialdiagnosen:** Aortensyndrom, Lungenembolie, Pneumothorax, Perikarditis, muskuloskelettaler Schmerz.

## ABCDE-Befunde

| | |
|---|---|
| A | Atemweg frei, kein Stridor. |
| B | AF 20/min, SpO2 96 % unter Raumluft, Thorax seitengleich, beidseits unauffälliges Atemgeräusch. |
| C | HF 96/min regelmäßig, RR 154/92 mmHg, Haut blass und kaltschweißig, Rekap < 2 s. |
| D | GCS 15, Pupillen isokor, BZ 118 mg/dl, keine fokal-neurologischen Ausfälle. |
| E | Keine Traumazeichen, Temp. 36,7 °C. |

### OPQRST

- O: plötzlich in Ruhe
- P: nicht atem- oder bewegungsabhängig
- Q: starker Druck / Enge
- R: linker Arm und Unterkiefer
- S: 8/10
- T: seit ca. 25 min

### SAMPLER

- S: Thoraxschmerz, Übelkeit, Kaltschweißigkeit
- A: keine bekannten Allergien
- M: Ramipril, Atorvastatin
- P: arterielle Hypertonie, Hypercholesterinämie
- L: Abendessen vor 3 h
- E: Beginn beim Fernsehen
- R: Raucher, positive Familienanamnese

## Zusatzbefund nur auf aktive Anforderung

Wenn ein 12-Kanal-EKG angefordert wird: ST-Hebungen inferior. Keine relevante Brady- oder Tachyarrhythmie.

### Erwartete Kernmaßnahmen

- ABCDE, Ruhe und körperliche Schonung
- Monitoring inkl. RR, SpO2 und EKG; 12-Kanal-EKG nach lokaler Kompetenz
- Keine routinemäßige Sauerstoffgabe bei ausreichender Oxygenierung
- Frühzeitige Nachforderung höherqualifizierter Rettungsmittel nach lokalem System
- Zeitkritische Transportentscheidung; bei passender EKG-Konstellation PCI-fähige Zielklinik
- Medikamentöse Therapie nur gemäß lokaler SOP/BPR/SAA und eigener Kompetenz
- Strukturierte Voranmeldung und Übergabe

### Verlauf

Bei adäquater Versorgung bleibt der Patient zunächst stabil. Bei Verzögerung nimmt der Schmerz auf 9/10 zu, HF 108/min.

### Fachgespräch

- Welche lebensbedrohlichen Differenzialdiagnosen gehören zu Thoraxschmerz?
- Warum wird bei SpO2 96 % nicht automatisch Sauerstoff gegeben?
- Welche Informationen muss die Zielklinik vorab erhalten?

### Trainingsbewertung (100 P.)

Gesamtsituation/Eigenschutz 15 | Geräte/Monitoring 15 | Sofortmaßnahmen/ABCDE 25 | Dokumentation/Reassessment 15 | Transport/Übergabe 15 | Assistenz/Eskalation 15

### Kritische Fehler

- Zeitkritischen Verlauf unterschätzen
- Keine Transport-/Zielentscheidung
- Medikamente außerhalb eigener Kompetenz ohne Rücksprache

# Krampfanfall beim Kleinkind

PRÜFLINGSKARTE

| | |
|---|---|
| Einsatzmeldung | **Krampfanfall, Kind 18 Monate** |
| Einsatzort | Wohnzimmer. Eltern sehr aufgeregt. |

### Situation beim Eintreffen

Beim Eintreffen ist der Krampf bereits beendet. Das Kind liegt schläfrig auf dem Arm des Vaters.

### Dein Auftrag

Versorge die Patientin bzw. den Patienten strukturiert. Befunde und Anamnesedaten erhältst du nur, wenn du sie aktiv erhebst oder die entsprechende Untersuchung/Maßnahme ankündigst. Begründe deine Prioritäten und triff am Ende eine Transport- und Übergabeentscheidung.

## Notizen / Arbeitsstruktur

**A** _____

**B** _____

**C** _____

**D** _____

**E** _____

**SAMPLER / OPQRST** _____

**Maßnahmen** _____

**Transport / Übergabe** _____

Kurztraining: 10-15 Min. | Prüfungssimulation NRW: 20-45 Min. inkl. Fachgespräch.

# Krampfanfall beim Kleinkind

### Patient / Ausgangslage

18 Monate, zuvor gesund. Generalisierter Krampf ca. 2 Minuten, spontan sistiert.

**Erster Eindruck:** Postiktal schläfrig, rosige Haut, fieberhaft.

### Lösung

**Arbeitshypothese:** Wahrscheinlicher einfacher Fieberkrampf.

**Differenzialdiagnosen:** Meningitis/Enzephalitis, Hypoglykämie, Epilepsie, Intoxikation.

## ABCDE-Befunde

| | |
|---|---|
| **A** | Frei, Schutzreflexe vorhanden. |
| **B** | AF 30/min, SpO2 97 %, unauffällige Atemarbeit. |
| **C** | HF 142/min, altersentsprechend kräftige Pulse, Rekap 2 s. |
| **D** | Postiktal, reagiert auf Eltern; BZ 96 mg/dl. |
| **E** | Temp. 39,4 °C, kein Exanthem, kein Trauma. |

### SAMPLER

- S: Fieber seit heute, kurzer generalisierter Krampf
- A: keine bekannten Allergien
- M: keine Dauermedikation
- P: gesund, altersgerechte Entwicklung

### SAMPLER (Fortsetzung)

- L: wenig getrunken
- E: Infekt der oberen Atemwege
- R: erster Krampfanfall

### Erwartete Kernmaßnahmen

- Kind möglichst bei Bezugsperson belassen, reizarm arbeiten
- ABCDE mit altersbezogenen Normwerten
- BZ und Temperatur erheben
- Nach Krampf Atemweg/Atmung sichern; bei erneutem anhaltendem Krampf eskalieren
- Keine aggressiven Kühlmaßnahmen; Komfort und Fieberursache beurteilen
- Warnzeichen für Meningitis/Sepsis oder komplexen Fieberkrampf suchen
- Transportentscheidung nach Alter, erstem Ereignis, Verlauf und lokalen Standards

### Verlauf

Kind wird nach einigen Minuten wacher, trinkt kleine Schlucke, bleibt fieberhaft. Kein erneuter Krampf.

### Fachgespräch

- Welche Kriterien sprechen für einen einfachen Fieberkrampf?
- Welche Warnzeichen würden die Einordnung verändern?
- Warum ist das Verhalten nach dem Krampf wichtig?

### Trainingsbewertung (100 P.)

Gesamtsituation/Eigenschutz 15 | Geräte/Monitoring 15 | Sofortmaßnahmen/ABCDE 25 | Dokumentation/Reassessment 15 | Transport/Übergabe 15 | Assistenz/Eskalation 15

### Kritische Fehler

- Kind gewaltsam festhalten
- Persistierende Bewusstseinsstörung oder Meningismus ignorieren
- Elternkommunikation vernachlässigen

# Kammerflimmern nach Thoraxschmerz

PRÜFLINGSKARTE

| | |
|---|---|
| Einsatzmeldung | **Bewusstlose Person, männlich, 62 Jahre** |
| Einsatzort | Wohnzimmer. Ehefrau führt nach Anleitung der Leitstelle Herzdruckmassage durch. |

### Situation beim Eintreffen

Der Patient liegt regungslos auf dem Boden. Die Ehefrau berichtet über plötzlichen Kollaps nach starken Brustschmerzen.

### Dein Auftrag

Versorge die Patientin bzw. den Patienten strukturiert. Befunde und Anamnesedaten erhältst du nur, wenn du sie aktiv erhebst oder die entsprechende Untersuchung/Maßnahme ankündigst. Begründe deine Prioritäten und triff am Ende eine Transport- und Übergabeentscheidung.

## Notizen / Arbeitsstruktur

**A** _____

**B** _____

**C** _____

**D** _____

**E** _____

**Reanimationsablauf** _____

**Maßnahmen** _____

**ROSC / Übergabe** _____

Kurztraining: 10-15 Min. | Prüfungssimulation NRW: 20-45 Min. inkl. Fachgespräch.

# Kammerflimmern nach Thoraxschmerz

### Patient / Ausgangslage

62 Jahre, männlich. Vor dem Kollaps ca. 15 Minuten Druck auf der Brust und Übelkeit.

**Erster Eindruck:** Bewusstlos, keine normale Atmung. Laienreanimation läuft.

### Lösung

**Arbeitshypothese:** Herz-Kreislaufstillstand mit Kammerflimmern, wahrscheinlich kardiale Ursache / ACS.

**Differenzialdiagnosen:** Andere reversible Ursachen des Kreislaufstillstands, insbesondere Hypoxie, Elektrolytstörung, Thrombose oder Spannungspneumothorax.

## ABCDE-Befunde

| | |
|---|---|
| **A** | Atemweg nicht gesichert; keine sichtbare Fremdkörperverlegung. |
| **B** | Keine normale Atmung, vereinzelte agonale Atemzüge. |
| **C** | Kein sicher tastbarer zentraler Puls; Monitor/AED zeigt bei Analyse einen schockbaren Rhythmus. |
| **D** | Bewusstlos. |
| **E** | Keine Hinweise auf Trauma; Umgebung sicher. |

**SAMPLER**

- S: vor Kollaps Thoraxschmerz und Übelkeit
- A: keine bekannten Allergien
- M: Ramipril, Atorvastatin
- P: Hypertonie, Hypercholesterinämie

**SAMPLER (Fortsetzung)**

- L: Abendessen vor 2 h
- E: plötzlicher Kollaps vor ca. 4 min
- R: Raucher, koronare Risikofaktoren

### Zusatzbefund nur auf aktive Anforderung

Bei Rhythmusanalyse: Kammerflimmern. Nach konsequenter Reanimation und Defibrillation tritt nach mehreren Zyklen ROSC ein.

**Erwartete Kernmaßnahmen**

- Kreislaufstillstand sofort erkennen und hochwertige CPR ohne vermeidbare Unterbrechungen fortsetzen
- Defibrillator/AED schnell anschließen und bei schockbarem Rhythmus unverzüglich defibrillieren
- Beatmung/Oxygenierung nach Ausbildungsstand und lokalem Standard sicherstellen
- ALS/Notarzt bzw. höhere Versorgungsstufe früh nachfordern
- Reversible Ursachen nach 4 H / 4 T strukturiert mitdenken
- Medikamente und erweiterte Maßnahmen nur gemäß lokaler Kompetenz/SOP
- Nach ROSC ABCDE, Oxygenierung, Kreislauf, 12-Kanal-EKG und geeignete Zielklinik priorisieren

**Verlauf**

Bei guter Teamleistung und früher Defibrillation ROSC nach mehreren Zyklen; Patient bleibt bewusstlos, hat aber wieder Spontankreislauf. Bei langen Pausen sinkt die Erfolgswahrscheinlichkeit.

**Fachgespräch**

- Was macht eine hochwertige CPR aus?
- Wann darf die Thoraxkompression für die Rhythmusanalyse/Defibrillation unterbrochen werden?
- Welche Prioritäten gelten direkt nach ROSC?

**Trainingsbewertung (100 P.)**

Gesamtsituation/Eigenschutz 15 | Geräte/Monitoring 15 | Sofortmaßnahmen/ABCDE 25 | Dokumentation/Reassessment 15 | Transport/Übergabe 15 | Assistenz/Eskalation 15

**Kritische Fehler**

- Kreislaufstillstand nicht erkennen oder CPR verzögern
- Schockbaren Rhythmus ohne Defibrillation weiterlaufen lassen
- Lange vermeidbare Unterbrechungen der Thoraxkompression